

Veiligheidsmanagement
'Bouwen aan Veiligheid in de Zorg'

Draaiboek
Veilig Incident Melden

VMS

Bouwen aan veiligheid in de zorg

www.vmszorg.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding 1

2. Incidenten melden, analyseren en verbeteren 2

2.1 Veilig Incident Melden 2
2.2 Analyseren van incidenten 5
2.3 Continu verbeteren 6

3. Doelen, indicatoren en voorwaarden 7

4. Stappenplan voor het invoeren van Veilig Incident Melden 9

4.1 Algemene projectopzet 9
4.2 Activiteiten in het ziekenhuis 9
4.3 Meldingsprocedure en meldingsformulier 11
4.4 Competenties, rollen en taakverdeling ten behoeve van het project 12

Bijlagen
Bijlage 1 Project Veiligheidsmanagement 13
Bijlage 2 Sneller Beter 14
Bijlage 3 Analysemethoden 15
Bijlage 4 Incidenten meldingsformulieren en meldprocedure 20
Bijlage 5 Risicomatrix 27
Bijlage 6 Referenties 28

1. Inleiding

Meldingssystemen verbeteren de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het meest genoemde doel van meldingssystemen is omschreven als: leren van eerdere ervaringen. Door het analyseren van grotere aantallen gebeurtenissen is het mogelijk om de onderliggende oorzaken op het spoor te komen en deze oorzaken weg te nemen. Deze oorzaken hebben niet zozeer te maken met het handelen van individuen, maar zijn vaker toe te schrijven aan organisatorische of systeemproblemen. De meeste incidenten zijn niet het gevolg van menselijke vergissingen, maar van een complex geheel van menselijke, organisatorische, technische en sociale aspecten en interacties. De meldingssystemen behoren niet, of bij uitzondering, te zijn gericht op het bestraffen van individuen. Het gaat vooral om het opsporen en herstellen van systeemfouten. De opzet van het meldingssysteem en de wijze van analyseren van gemelde informatie moeten daarop zijn gericht. Centraal staat een systematische analyse van gegevens.

"Een veilig melden systeem wordt getypeerd als een systeem waarbinnen hulpverleners in de zorg gestimuleerd worden om onvoorziene en mogelijk schadelijke gebeurtenissen zoals fouten, bijna-fouten, complicaties en incidenten te melden op afdelingsniveau en te bespreken, zonder te hoeven vrezen voor disciplinaire maatregelen of juridische procedures. De algemene verwachting is dat door veilig melden systemen te introduceren de bereidheid van hulpverleners om incidenten of fouten te melden zal toenemen. Daarmee komt veel informatie beschikbaar waarvan hulpverleners en instellingen (veel) kunnen leren. Door gebruik te maken van die informatie kunnen maatregelen genomen worden die zullen leiden tot vermindering c.q. voorkoming van (bijna-) fouten in de toekomst, en daarmee tot vergroting van de patiëntveiligheid en kwaliteit van de te leveren zorg. Naar schatting overlijden er jaarlijks 1500 tot 1600 mensen in Nederlandse ziekenhuizen als gevolg van incidenten die te voorkomen waren geweest. De Inspectie huldigt het standpunt dat instellingen een grote verantwoordelijkheid hebben bij het creëren van een goed klimaat waarbinnen hulpverleners incidenten en fouten willen melden." (Legemaate 2006)

Dit draaiboek is opgesteld voor de teams die op de afdelingen Veilig Incident Melden gaan invoeren en is te gebruiken door verpleegkundigen, medisch specialisten, arts-assistenten, leidinggevenden en anderen die betrokken zijn bij de zorg.

In dit draaiboek komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Incident melden, analyseren en verbeteren
2. Doelen, indicatoren en voorwaarden
3. Stappenplan voor het invoeren van incident melden

De basis van dit draaiboek is ontwikkeld binnen het project Sneller Beter pijler 3 (SBp3) en aangepast in samenwerking met het project vmszorg.nl. Het draaiboek is gebruikt binnen de SBp3 ziekenhuizen en de VMSzorg pilotziekenhuizen en vormt in beide programma's een belangrijk onderdeel. Daarom is gekozen om de inhoud van het draaiboek Veilig Incident Melden zodanig aan te passen dat in beide projecten hetzelfde draaiboek gebruikt wordt.

Het draaiboek richt zich hoofdzakelijk op het implementeren van VIM. Het analyseren van incidenten met beschikbare analyse methode wordt slechts kort besproken. Om uw organisatie ook daarin de ondersteunen is in het project VMSzorg.nl een e-learning module voor de analyse methode PRISMA ontwikkeld. Het draaiboek en de e-learning zijn beschikbaar gesteld op de website www.vmszorg.nl.

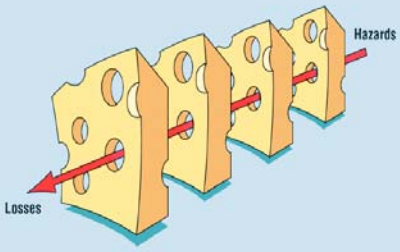
De eisen om incidenten te rapporteren en analyseren in uw organisatie zijn opgenomen in de Nederlands Technische Afspraak NTA 8009:2007, die binnen het project veiligheidsmanagement in samenwerking met 30 partijen is opgesteld. Meer informatie kunt u vinden op www.vmszorg.nl.

2. Incidenten melden, analyseren en verbeteren

2.1 Incident melden

De ziekenhuizen die deelnemen aan het project Veiligheidsmanagement en SBp3 implementeren, hebben een laagdrempelig meldingssysteem. Dit heeft als doel te leren van ongewenste gebeurtenissen en te komen tot een classificatie van basisoorzaken. Ongewenste gebeurtenissen zijn alle gebeurtenissen (of uitkomsten van gebeurtenissen) die afwijken van het normale zorgproces. Niet-bedoelde uitkomsten van ingrepen, falen van mens, organisatie en techniek, en onduidelijkheid in procedures vormen meldingsmomenten in het zorgproces.

Ongewenste gebeurtenissen in het zorgproces hebben lang niet altijd consequenties voor patiënten. Dit komt omdat in het proces van zorgverlening barrières zijn ingebouwd ter voorkoming van schade aan patiënten. James Reason laat dit zien in zijn Swiss cheese model (BMJ Volume 320; 18 March 2000). Vergissingen worden vaak tijdig onderkend en medewerkers hebben dan de mogelijkheid om de fout te herstellen.



De vergissingen die wel leiden tot schade bij patiënten zijn slechts het topje van de ijsberg (Kaplan et al; TRANSFUSION Volume 38, NovemberDecember 1998). Juist door ook te leren van ongewenste gebeurtenissen die niet leiden tot directe schade (maar vaak wel het resultaat zijn van dezelfde oorzakelijke factoren als incidenten) is het aantal risicomomenten in de zorg te verminderen en kunnen bestaande barrières worden verstevigd of extra ingebouwd.

Een andere aanpak

Op dit moment werken de meeste ziekenhuizen met een MIP (Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg). Deze commissie levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering (patiëntveiligheid) door binnengekomen meldingen te analyseren en aanbevelingen te doen (veelal aan de Raad van Bestuur). Veel MIP-commissies kampen echter met problemen, zoals het meldcriterium (wat moet er wel en niet gemeld worden) en de meldingsbereidheid. Medewerkers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de werkwijze van de MIP-commissie, het kost te veel moeite om het meldingsformulier in te vullen en medewerkers zien doorgaans niet wat de MIP-commissie met de melding doet. Een andere aanpak voor het melden van incidenten is dus gewenst; een veilig incident meldingssysteem kan hiervoor een oplossing zijn.

Veilig Incident Meldingssysteem

Het Veilig Incident Meldingssysteem (het VIM-instrument) is bedoeld om (snel) zicht te krijgen op het hoe en waarom van ongewenste gebeurtenissen in het zorgproces. Daarbij staat niet de vergissing van een persoon centraal, maar de condities waaronder mensen werken en de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Op het moment dat een ongewenste gebeurtenis optreedt, vraagt men zich niet af door wie het komt, maar hoe het komt dat de veiligheidsmechanismen (barrières) van het systeem niet gewerkt hebben. Deze benadering voorkomt een ‘blaming’ cultuur, een aan een persoon toeschrijven van de ongewenste uitkomst.

In de literatuur worden de volgende karakteristieken genoemd voor een succesvol incident meldingssysteem:

- non-punitive:	*Reporters are free of fear of retaliation or punishment from others as a result of reporting.*
- confidential:	*The identities of the patient, reporter and institution are never revealed to a third party.*
- independent:	*The program is independent of any authority with power to punish the reporter or. organization.*
- expert analysis:	*Reports are evaluated by experts who understand the clinical circumstances and who are trained to recognize underlying system causes.*
- timely:	*Reports are analyzed promptly and recommendations are rapidly disseminated to those who need to know, especially when serious hazards are identified.*
- systems-oriented:	*Recommendations focus on changes in systems, processes of products rather than on individual performance.*
- responsive:	*The agency that receives reports is capable of disseminating recommendations and participating organizations agree to implementing recommendations when possible.*

(Leape, Lucian L., Reporting of adverse events, N Engl J Med, Vol. 347, No. 20, nov 14, 2002, p. 1633-1638)

Bovenstaande punten zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 van dit draaiboek onder de voorwaarden.

De term 'blame-free' is te veel verbonden met het 'blamen' van mensen bij het maken van fouten. Daarom is gekozen om in dit draaiboek uit te gaan van 'Veilig Incident Melden' of VIM. Voor het op eigen initiatief melden van ongewenste gebeurtenissen is een omgeving noodzakelijk waar iedereen bereid is om open over deze gebeurtenissen te praten, zodat de oorzaken opgespoord kunnen worden en verbeteracties ingezet. Dit moet een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk zijn.

Daarnaast staat VIM ook voor:
- Vergissen Is Menselijk
- Vrijwillig Incidenten Melding
- Vanzelfsprekend Incident Melden

Commitment

Om VIM te positioneren, onderschrijft de Raad van Bestuur van het ziekenhuis het belang van het melden van incidenten voor het verminderen van risicomomenten in de patiëntenzorg en voor de veiligheid van medewerkers en verwerkt dat in het Veiligheidsplan. Op ziekenhuisniveau draagt de Raad van Bestuur zorg voor de randvoorwaarden, zoals commitment van de leiding en het management voor een Veiligheidsmanagementsysteem in het algemeen en VIM in het bijzonder, het garanderen van de vertrouwelijkheid van meldingen en het vrijmaken van financiële middelen om een dergelijk systeem mogelijk te maken. Bovendien moet vooraf duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheden liggen als de oorzaken en/of gevolgen afdelingsoverschrijdend zijn. Een omgeving waarin vertrouwen en veiligheid is om ongewenste gebeurtenissen te melden, is waarschijnlijk het beste op afdelingsniveau te realiseren.

Afdelingscommissie voor meldingen

Een afdeling die VIM introduceert, stelt een afdelingscommissie voor meldingen in. De rol van de afdelingscommissie wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 4. Deze commissie maakt met de centrale meldingscommissie (of MIP-commissie) afspraken over de werkwijze van de beide commissies ten opzichte van elkaar. Zo kan een lid van de centrale commissie zitting hebben in de afdelingscommissie of worden de melding, analyse en verbeteracties door de afdelingscommissie besproken met de centrale commissie. De afdelingscommissie analyseert de meldingen en initieert verbeteracties en koppelt dit zo

nodig terug naar de centrale commissie. Vervolgens wordt bepaald of de melding centraal in behandeling wordt genomen. De centrale commissie laat dat weten aan de afdelings-commissie en de melder.

Toename van meldingen

Aannemelijk is dat in de eerste periode na invoering van VIM het slechts zal gaan om enkele meldingen per maand. Als het systeem naar behoren functioneert, zullen de meldingen gestaag toenemen en is de verwachting dat het op afdelingsniveau uiteindelijk om enige honderden meldingen per jaar zal gaan. Omdat verpleegkundigen en arts-assistenten relatief veel directe patiëntcontacten hebben, is het aannemelijk dat het aantal meldingen uit deze disciplines hoger zal liggen dan het aantal meldingen gedaan door medisch specialisten. Het is echter cruciaal dat ook medisch specialisten melden.

Ervaringen van anderen

Binnen de Nederlandse gezondheidszorg wordt steeds meer ervaring opgedaan op het gebied van Veilig Incident Melden, bijvoorbeeld binnen de Isala klinieken, het Erasmus MC, de Sneller Beter ziekenhuizen en de ziekenhuizen die meedoen aan het project Veiligheidsmanagement.
Internationaal zijn er goede voorbeelden in Australië, Amerika, Engeland (NRLS; national reporting and learning system) en Denemarken (waar naast het recent invoeren van de wet op patiëntveiligheid ook vorm wordt gegeven aan een national reporting system). Ook heeft men binnen de chemie- en staalindustrie al tientallen jaren ervaring met het reduceren van risico's. We kunnen veel leren van de ervaringen en de instrumenten die binnen deze industrieën worden toegepast.

Complicatieregistratie

Aanvullend aan het Veilig Incident Melden kan men ook complicaties registreren. Bij complicatieregistratie gaat het om het registreren van ongewenste gezondheidsuitkomsten, bijvoorbeeld infectie of bloeding. Expliciet wordt vastgelegd of er wel of geen complicatie heeft plaatsgevonden en zo ja, het specificeren van de complicatie en de context. Hiermee kan een 'evidence base' worden opgebouwd, waarmee inzicht in incidentie en risico's kan worden verkregen.

Complicatieregistratie kan ook als kwaliteitsinstrument voor en door medisch specialisten gebruikt worden. De Orde van Medisch Specialisten werkt met het programma complicatie-registratie aan drie doelen:

1. het ontwikkelen van landelijke standaarden;
2. het per wetenschappelijke vereniging invulling geven aan een complicatieregistratie;
3. het ondersteunen van ziekenhuisbrede complicatieregistratie.

Complicatieregistratie is geen onderdeel van het Veilig Incident Melden. Specifiek gaat de aandacht uit naar het registeren en analyseren van incidenten.

Complicaties, incidenten en bijna ongelukken met patiënten en zorgverleners, maar ook signalen vanuit de patiënt over onveilige situaties (bijvoorbeeld uiting van zorgen over veiligheid, of melding van een fout of klacht) vormen de input voor het (reactief) veiliger maken van processen. Het gaat om het beperken van vermijdbare schade aan de patiënt. Soms is het echter lastig om een onderscheid te maken tussen natuurlijk verloop en vermijdbare schade.

2.2 Analyseren van incidenten

De methode RCA of SIRE

Om zoveel mogelijk te leren van meldingen van ongewenste gebeurtenissen, is het van belang deze meldingen systematisch te analyseren. Dit kan met behulp van de methode van *Root Cause Analysis (RCA).* In Nederland noemen we deze methode ook wel Systematisch Incident Analyse en Reconstructie (SIRE). Deze methode stelt de volgende vragen centraal: wat, hoe en waarom? Om een beeld te krijgen van het 'wat' en het 'hoe' wordt de melder gevraagd een duidelijke beschrijving te geven van de gebeurtenis op een daarop toegespitst meldingsformulier. Door de opzet van dit meldingsformulier wordt duidelijk in welke situatie de gebeurtenis plaatsvond, welke menselijke, technische en systeemfactoren van invloed waren en welke factoren het effect van de ongewenste gebeurtenis hebben beperkt. Een voorbeeld meldingsformulier en -procedure is te vinden in bijlage 4. Door een risicomatrix (zie bijlage 5) in het formulier op te nemen, is snel duidelijk of onmiddellijke actie is gewenst en wie daartoe bevoegd en uiteindelijk ook verantwoordelijk voor is of gesteld kan worden. De afdelingscommissie die de melding analyseert, stelt vervolgens net zo vaak de 'waarom'-vraag totdat de basisoorzaak (oorzakelijke factor) is gevonden.

De methode PRISMA

Een andere veel gebruikte methode is *Prevention and Recovery Information system for Monitoring and Analysis (PRISMA).* Deze methode bestaat uit drie belangrijke componenten, te weten:

1. Incidentbeschrijving;
2. Oorzakenclassificatie;
3. Vertaalslag naar structurele maatregelen.

Incidenten worden eerst beschreven in de vorm van 'oorzakenbomen'. Vervolgens worden de 'basisoorzaken' (die per incident door middel van de bijbehorende oorzakenboom zijn geïdentificeerd) stuk voor stuk geclassificeerd via een theoretisch model van technische, organisatorische en menselijke faaloorzaken. Ten slotte wordt periodiek een aantal incidenten integraal geïnterpreteerd in termen van de meest effectieve verbetermaat-regelen. Beide methoden worden uitgebreid toegelicht in bijlage 3. Als in de inleiding aangegeven wordt vanuit vmszorg.nl werken met de PRISMA methode ondersteund door een e-learning module.

Binnen het project Veiligheidsmanagement is gekozen om met de PRISMA methode te analyseren. Deze methode kent een classificatiesysteem waardoor trends gesignaleerd kunnen worden en waarop verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Deze methode is geschikt om snel en efficiënt (op afdelingsniveau) incidenten te analyseren en acties te ondernemen. De methode wordt in verschillende instellingen succesvol toegepast en wordt daarnaast door de Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt. Bij de SIRE methodiek wordt een diepgravender onderzoek naar basisoorzaken van een incident verricht door bijvoorbeeld dossieronderzoek en interviews. De SIRE methodiek wordt vooral gebruikt bij grote incidenten en incidenten die veel voorkomen. Deze methode is tijdrovender dan de PRISMA methodiek.

2.3 Continu verbeteren

Op basis van de uitkomsten van de analyse kunnen verbeteringen in het zorgproces worden aangebracht. Om aan te tonen dat veranderingen een verbetering tot stand hebben gebracht, is het noodzakelijk om te meten. Het is goed om in de gaten te houden dat meten hierbij geen doel op zich is, maar een hulpmiddel.

Het Nolan-verbetermodel

Bij het invoeren van verbetermaatregelen kan het Nolan-verbetermodel behulpzaam zijn. De essentie van het Nolan-verbetermodel is het snel en op kleine schaal invoeren en testen van verbeteringen. Op deze manier zijn werkprocessen stapsgewijs te veranderen, terwijl je tussendoor steeds alert bent of dit het gewenste resultaat oplevert. Alleen bij gebleken succes wordt de verbetering op grotere schaal ingevoerd.

Het model bestaat uit twee onderdelen:

1. de drie kernvragen:
   - wat willen we bereiken?
     Voorbeeld: In 2007 is het aantal meldingen met 400% toegenomen ten opzichte van 2006.
   - hoe weten we dat een verandering een verbetering is?
     Voorbeeld: Aantal meldingen in de desbetreffende periode tellen.
   - welke veranderingen kunnen we invoeren die resulteren in een verbetering?
     Voorbeeld: Instellen afdelingscommissie, invoeren VIM instrument, invoeren PRISMA methode, analyse en verbetermaatregelen terugkoppelen naar de afdeling.

2. de Plan-Do-Study-Act (PDSA) cyclus waarmee veranderingen worden getest en ingevoerd in de praktijk.
   Voorbeeld:
   - Plan: schrijf een plan van aanpak voor het melden van incidenten (zie draaiboek VIM);
   - Do: voer het plan van aanpak uit;
   - Study: evalueer en meet of de doelstelling is behaald;
   - Act: stel zonodig het plan bij en handel hiernaar.

   Hieronder een schematische weergave van het Nolan-verbetermodel:



Op de website www.vmszorg.nl is de handleiding en een e-learning ‘SMART en betrouwbaar verbeteren’ beschikbaar.

3. Doelen, indicatoren en voorwaarden

Om VIM succesvol te implementeren zullen doelstellingen moeten worden gesteld waar de afdeling naar toe werkt. Ook binnen het project Veiligheidsmanagement (www.vmszorg.nl) waren voor het Veilig Incident Melden een aantal doelen en indicatoren gesteld. Als u gaat starten met VIM kunt u onderstaande doelstellingen overnemen of naar eigen behoefte aanpassen.

Doelen en indicatoren

Eén jaar na de start van Veilig Incident Melden heeft een ziekenhuis bereikt dat:

- op minimaal vijftig procent van de verpleeg/behandelafdelingen, een incident meldingssysteem is ingevoerd;
- het aantal meldingen op die afdelingen ten opzichte van de oorspronkelijke aantallen MIP/FONA meldingen minimaal is verdubbeld. Het gaat hierbij om alle ongewenste gebeurtenissen al dan niet met consequenties voor patiënten. Ook ongewenste gebeurtenissen die betrekking hebben op de veiligheid van personeel worden gemeld;
- een registratie en analyse van basisoorzaken per deelnemende afdeling is opgezet;
- een systeem is opgezet waaruit, op basis van de gemelde incidenten, verbeteringen worden ingezet, door bijvoorbeeld gebruik te maken van het Nolan-verbetermodel;
- bij vijf of meer categorieën van ongewenste uitkomsten per deelnemende afdeling initiatieven op gang zijn gebracht om op basis van de analyse van ongewenste gebeurtenissen uit de VIM registratie verbeterslagen te maken;
- uitwisseling van meldingen en ervaringen tussen afdelingen binnen het eigen ziekenhuis plaatsvindt;
- rapportage plaatsvindt van ervaringen van alle deelnemende ziekenhuizen binnen de pilot VMS onderling en via de projectcoördinatoren aan de landelijke projectgroep VMS.

Het doel van het landelijke project Veiligheidsmanagement was het basiselement VIM op basis van bestaand materiaal te ontwikkelen en te optimaliseren met de tien pilotziekenhuizen, zodat het per 1 juni 2007 op landelijk niveau kon worden aangeboden aan alle ziekenhuizen en zorginstellingen.

Voorwaarden

Voor het succesvol invoeren van een veilig incident meldingssysteem moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan voor aanvang van het project:

Voorwaarden ziekenhuis:

1. een open cultuur waarbij het melden van incidenten vanzelfsprekend is;
2. commitment van de Raad van Bestuur aanwezig, evenals structuur en deskundigheid om VIM ziekenhuisbreed te realiseren;
3. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedefinieerd met betrekking tot het meldingssysteem op afdelings- en ziekenhuisniveau;
4. opleiden van leden van afdelingscommissies, de projectcoördinator en een afvaardiging van de centrale MIP commissie in het analyseren van incidenten, interpreteren van resultaten, het vertalen daarvan naar concrete (preventieve) acties en het leggen van verbanden tussen andere kwaliteitsprojecten binnen het ziekenhuis;
5. budget voor het realiseren van verbeteringen. Niet alle verbeteringen kosten geld, maar soms is het noodzakelijk om te investeren.

Voorwaarden afdeling:

1. instellen van een afdelingscommissie voor meldingen;
2. beschikbaar stellen van tijd aan leden van de afdelingscommissie voor het opzetten en draaiende houden van VIM;
3. trainen van de leden van de afdelingscommissie om basisoorzaken uit een melding te kunnen analyseren en registreren;
4. snel (binnen een maand) terugkoppelen van ondernomen acties aan de melder en de afdeling, bijvoorbeeld tijdens het afdelingsoverleg;
5. volgen van een training op afdelingsniveau om op basis van analyse van meldingen kortcyclisch te leren verbeteren;
6. inzichtelijk maken van verbeteringen die gerealiseerd zijn op basis van meldingen;
7. uitwisselen van urgente meldingen met andere afdelingen en de andere ziekenhuizen binnen de pilot VMS;
8. afspraken maken met de centrale meldingscommissie (MIP) en de Raad van Bestuur over de terug te koppelen meldingen;
9. structureel overleg met de centrale MIP-commissie van het ziekenhuis. Daarnaast ook schriftelijke rapportage (bijvoorbeeld 2 keer per jaar) naar de MIP-commissie;
10. overleg met de projectgroep patiëntveiligheid (of een vergelijkbaar gremium) van het ziekenhuis.

Algemene voorwaarden van veilig melden:
"Melden op afdelingsniveau heeft vanuit een perspectief van patiëntveiligheid voordelen, maar kan ook eigen problemen op het punt van de veiligheid met zich meebrengen. Het is niet ondenkbaar dat melden op de eigen afdeling juist als onveiliger wordt ervaren, dan het melden van een incident aan een MIP commissie op instellingsniveau. Bijvoorbeeld omdat alle betrokkenen elkaar kennen en er - juist daardoor - toch meer aandacht uitgaat naar de melder dan naar het gemelde incident. Bepalend is hier in de eerste plaats de bestaande cultuur.
Medewerkers van een instelling moeten erop kunnen vertrouwen dat collega's en (afdelings-of instellings)-management zorgvuldig omgaan met meldingen en de daarin opgenomen informatie. Dat vertrouwen kan verder worden versterkt door de wijze waarop de procedure is ingericht en door duidelijke afspraken over het beleid en de handelwijze van werkgever c.q. instellingsmanagement.
Deze afspraken zullen als uitgangspunt moeten hebben dat het melden en analyseren van incidenten enerzijds en het treffen van maatregelen tegen individuen anderzijds gescheiden trajecten zijn.

De bescherming van de melder kan nimmer absoluut zijn. In situaties van opzet of grove onachtzaamheid, of in het geval van incidenten met een zeer ernstige afloop, is het niet aanvaardbaar dat de betrokken hulpverlener aanspraak zou kunnen maken op bescherming tegen maatregelen of procedures."
(Legemaate J, 2006)

4. Stappenplan voor het invoeren van Veilig Incident Melden

4.1 Algemene projectopzet

Bij het implementeren van VIM binnen de organisatie is het belangrijk om een verspreidingsstrategie te hanteren. Start, als de tien pilotziekenhuizen in het VMSzorg project en SBp3, met een aantal afdelingen. In de tweede ronde, wanneer nieuwe afdelingen starten, fungeren de afdelingen uit de eerste ronde als 'best practice' voor de nieuwe afdelingen. In deze paragraaf wordt de opzet beschreven. De projectopzet gaat uit van een start met twee à drie deelnemende afdelingen per ziekenhuis. In de tweede ronde gaan zes tot negen afdelingen van start. Eén jaar na de start van het Veilig Incident Melden wordt het incident melden op minimaal vijftig procent van de behandel/klinische afdelingen ingevoerd. VIM is gericht op het uitvoeren van veranderingen die via bewustwording leiden tot verminderde schade aan de patiënt. VIM is sterk actie- en resultaatgericht waarbij alle professionals van de betreffende afdeling participeren.

4.2 Activiteiten in het ziekenhuis

Het ziekenhuis dient ook een aantal activiteiten te ondernemen om Veilig Incident Melden in te voeren. De activiteiten zijn in chronologische volgorde beschreven, maar kunnen elkaar deels overlappen.

1. Instellen van de meldingscommissie
   Elke deelnemende afdeling stelt een commissie in die meldingen verzamelt en analyseert. In deze commissie hebben in ieder geval de volgende personen zitting:
   - Medisch specialist (als voorzitter/trekker van de commissie)
   - Leidinggevende (hoofd van de afdeling/management)
   - Verpleegkundige(n)
   - Arts-assistent

   Optioneel:
   - Kwaliteitsfunctionaris (kan plaatsnemen in de commissies in de opstartfase)
   - Secretariaat
   - Discipline die veel met de afdeling te maken heeft, bijvoorbeeld fysiotherapie, ziekenhuisapotheek, et cetera.

   Vooral verpleegkundigen, medisch specialisten en arts-assistenten spelen een belangrijke rol bij het melden van incidenten vanwege de vele patiëntcontacten.

   De afdelingscommissie heeft de volgende taken:
   - ontwikkelen/aanpassen van een meldformulier en -procedure;
   - stimuleren van medewerkers om incidenten te melden;
   - verzamelen van de incidenten op de afdeling. Iedere medewerker op een afdeling (inclusief arts-assistent en medisch specialist) is (kunnen namelijk ook voor/over anderen melden) verantwoordelijk voor het melden van incidenten;
   - analyseren van incidenten;
   - terugkoppelen van de resultaten;
   - zorgdragen dat verbeteringen worden ingevoerd;
   - afstemmen met de MIP-commissie.

Elk lid van de afdelingscommissie zal ongeveer twee tot vier uur per week bezig zijn met het afhandelen, analyseren en terugkoppelen van de maatregelen. De meeste afdelingscommissies vergaderen één keer per twee weken. Dit is afhankelijk van het aantal meldingen.

2. Evaluatie van de MIP/FONA/klachten meldingen
   Voordat de afdelingscommissie start, kan zij retrospectief onderzoek doen naar de MIP-meldingen of klachten van de afgelopen vijf jaar om een beeld te krijgen van de soort en het aantal meldingen van de betreffende afdeling. Dit kan tevens als nulmeting dienen voor evaluatie van de interventies.

3. Opstellen meldingsprocedure en meldformulier
   De commissies van de afdelingen die als eerste starten, ontwikkelen een meldformulier en een meldprocedure (zie paragraaf 4.3.1) die als voorbeeld dienen voor het hele ziekenhuis. In bijlage 3 is een voorbeeld meldformulier en -procedure te vinden.
   Binnen het project Veiligheidsmanagement wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een digitaal meldsysteem voor het melden, analyseren en afhandelen van incidenten.

4. Afstemming VIM en MIP
   De afdelingscommissies maken afspraken met de centrale commissie (MIP-commissie) welke meldingen en op welke manier meldingen worden doorgestuurd naar de MIP-commissie. Ook bij afdelingsoverschrijdende interventies speelt de MIP-commissie een rol. Ook de Raad van Bestuur en de eventuele projectgroep/stuurgroep patiëntveiligheid kunnen hierbij worden betrokken.

5. Start Veilig Incident Melden
   Na afronding van in ieder geval de stappen 1 tot en met 4 kan een afdeling starten met het melden van incidenten. De afdelingscommissie heeft een belangrijke rol om medewerkers te motiveren om incidenten te melden. Na een introductie van het doel van VIM, het meldformulier en de meldingsprocedure op de afdeling, start het Veilig Incident Melden. De afdelingscommissie analyseert de meldingen en stelt op basis hiervan SMART (SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Appellerend, Resultaatgericht en Tijdgebonden) doelen en verbeteracties voor. De afdelingscommissie stelt regelmatig de afdeling op de hoogte van de voortgang. Tevens kunnen medewerkers van de afdeling hun ervaringen en suggesties doorgeven.
   Om een cultuurverandering op de afdeling te realiseren, is het aan te raden om incidenten, inclusief de analyse en verbetermaatregelen, in teamverband te bespreken, bijvoorbeeld tijdens afdelingsoverleg. Daarnaast kan een incident ook benoemd worden tot incident van de week of kan het onderwerp patiëntveiligheid standaard op de agenda van het afdelingsoverleg staan. Ook zijn nog andere interventies te gebruiken om de veiligheidscultuur op een afdeling positief te beïnvloeden, zoals Veiligheidsrondes. Deze interventie is in dit draaiboek niet verder uitgewerkt, maar wordt wel aangeboden binnen het project Veiligheidsmanagement.

6. Evaluatie
   Drie, zes en twaalf maanden na de start evalueert de afdelingscommissie de ervaringen en stelt het meldingsformulier en de meldingsprocedure zonodig bij.
   De afdelingen die starten met incident melden kunnen tijdelijk een projectgroep vormen om ervaringen met elkaar te delen. Een beleids- of stafmedewerker kwaliteit kan hier een leidende rol in vervullen.

7. Verspreiden VIM naar andere afdelingen
   Na ongeveer een half jaar zullen nieuwe afdelingen starten met VIM die op dezelfde wijze ondersteund worden als de eerste afdelingen. Daarnaast kan de tweede groep afdelingen ook gebruik maken van de ervaringen van de eerste afdelingen. Deze afdelingen moeten in een vroeg stadium bekend zijn.

8. Overige activiteiten
   Op ziekenhuisniveau wordt aan de volgende onderwerpen aandacht besteed:
   - overleg en terugkoppeling met andere afdelingen waar een dergelijk systeem in werking is;
   - relatie met MIP-commissie en advisering aan de RvB;
   - beleid calamiteiten (melden aan de RvB, die een meldingsplicht heeft aan de inspectie);
   - koppeling projectgroep patiëntveiligheid op ziekenhuisniveau;
   - invoeren van basisoorzaken in centrale database;
   - afspraak over de plaats waar de gegevens worden opgeslagen en bewaakt;
   - publiciteit geven aan belangrijke uitkomsten (bijvoorbeeld met flyers);
   - mogelijkheid voor een digitaal meldsysteem met daaraan gekoppeld een tool voor managementrapportage.

4.3 Meldingsprocedure en meldingsformulier

Zoals in onderdeel 4.3 is vernoemd, stelt de meldingscommissie van iedere afdeling een meldingsprocedure en een meldformulier op. Dit kan op ziekenhuisniveau worden ingestoken zodat de procedure en het formulier ziekenhuisbreed toepasbaar zijn.

Meldingsprocedure
De eerste afdelingen die starten met de introductie van VIM maken een meldingsprocedure die voor andere afdelingen in het ziekenhuis model staat. In een meldingsprocedure komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- melden met behulp van het meldingsformulier binnen x dagen;
- afspraken over anonimiteit en melding in het patiëntendossier;
- ontvangstbericht naar melder (en nazorgprocedure) binnen x dagen;
- structurele bijeenkomsten van de afdelingscommissie om meldingen te analyseren, waarbij de melder op vrijwillige basis wordt uitgenodigd als zijn melding wordt geanalyseerd;
- analyse van melding: ernst van de melding vaststellen (risico-inschatting: zie bijlage 5) en basisoorzaken bepalen (bijvoorbeeld met oorzakenboom of 5 x waarom), basisoorzaken categoriseren;
- verbeteracties vaststellen (SMART geformuleerd) op basis van evidence en best practice, invoeren en evalueren (volgens PDSA: zie hoofdstuk 2);
- borgen en bespreken van meldingen en acties in afdelingsoverleg.

Meldingsformulier

Onderdeel van de procedure is het ontwerpen van een meldingsformulier. Meldingsformulieren verschillen wat betreft inhoud en vormgeving. Een meldingsformulier bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

- beschrijving van de ongewenste gebeurtenis (tijd, plaats);
- de omstandigheden waaronder de ongewenste gebeurtenis plaats vond (situatie);
- mogelijke oorzaken van deze ongewenste gebeurtenis (welke technische, organisatorische en menselijke factoren waren van invloed);
- effecten/consequenties van de ongewenste gebeurtenis;
- welke acties zijn vervolgens ondernomen om schade te voorkomen of te beperken (herstelfactoren).

Door ziekenhuisbreed gebruik te maken van een digitaal meldsysteem is standaardisatie intern mogelijk. Het project Veiligheidmanagement streeft naar een landelijke standaardisatie om uitsluitsel te kunnen geven over het aantal incidenten, welke incidenten het meeste voorkomen en welke gevolgen dit heeft voor de patiënt. Zie voor twee voorbeelden van een meldingsformulier bijlage 4.

4.4 Competenties, rollen en taakverdeling ten behoeve van het project

Afdelingscommissie:

- is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, invoeren, bijstellen en draaiende houden van VIM;
- heeft een coachende rol voor startende commissies van nieuwe afdelingen;
- onderhoudt nauw contact met de MIP commissie, Raad van Bestuur.

Beleids- of kwaliteitsmedewerk veiligheid:

- neemt deel aan een afdelingscommissie (optioneel);
- begeleidt de afdelingen bij het opzetten en bijstellen van de meldingsprocedure en het meldingsformulier;
- biedt zonodig ondersteuning bij de verschillende stappen van VIM, zoals het achterhalen van basisoorzaken van een bepaalde melding;
- verspreidt Veilig Incident Melden in het ziekenhuis;
- is de contactpersoon voor het landelijke project Veiligheidsmanagement.

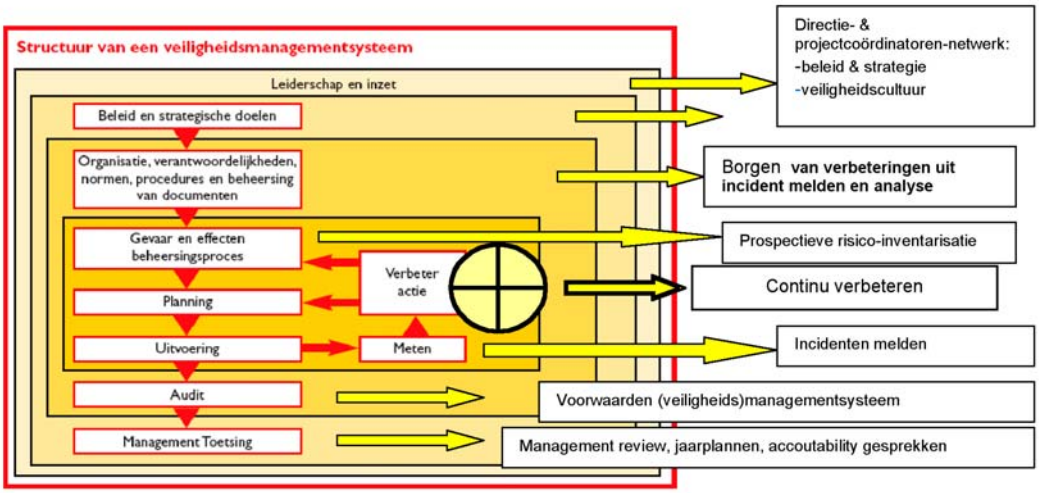
Bijlage 1 Project Veiligheidsmanagement

In het kader van Sneller Beter (www.snellerbeter.nl) heeft Rein Willems van Shell (www.shell.nl) in 2004 een rapport over veiligheid in de zorg gepresenteerd: 'Hier werk je veilig, of je werkt hier niet' (Willems, 2004). In dit rapport worden vier aanbevelingen gegeven waarmee de veiligheid in de zorg vergroot kan worden:

1. Alle ziekenhuizen werken in 2008 met een gecertificeerd veiligheidsmanagement-systeem (VMS);
2. Directies moeten eindverantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid;
3. Verzekeraars nemen veiligheid en kwaliteit mee in contractbesprekingen;
4. De overheid moet daadkracht en verantwoordelijkheid tonen.

Dit rapport is heeft er mede toe bijgedragen dat de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging een project zijn gestart onder de naam: 'Veiligheidsmanagement, bouwen aan veiligheid in de zorg'.
In het project worden de eerste twee aanbevelingen uit het rapport uitgewerkt. De andere twee aanbevelingen van Willems zullen niet expliciet worden opgepakt. In eerste instantie willen de drie organisaties de ziekenhuizen ondersteunen bij het implementeren van veiligheidsmanagement.

Rein Willems heeft een aantal basiselementen benoemd waaruit een veiligheidsmanagementsysteem zou moeten bestaan. De samenhang tussen het project Veiligheidsmanagement en de structuur van een veiligheidsmanagementsysteem geschetst door Rein Willems is te zien in figuur 1.



Figuur 1 Het VMS rapport Willems (2004) en de onderdelen van het project VMS (rechts)

De basiselementen van het VMS zijn binnen het project vormgegeven en desgewenst ontwikkeld in samenwerking met tien pilotziekenhuizen. Het project heeft de verschillende elementen in de pilotziekenhuizen toegepast om vervolgens door uitwisseling van ervaringen en bijstellen van de instrumenten te komen tot instrumenten die breed toepasbaar zijn bij overige algemene en categorale ziekenhuizen en zorginstellingen. De resultaten en de ontwikkelde instrumenten zijn alle beschikbaar op de website www.vmszorg.nl.

Bijlage 2 Sneller Beter

Verbetering van transparantie, doelmatigheid en kwaliteit

Het programma Sneller Beter is 20 november 2003 gestart om een verbetering van transparantie, doelmatigheid en kwaliteit in de curatieve zorg te stimuleren. Het moet sneller om de zorg op tijd beschikbaar te krijgen, zodat wachten op de zorg binnen aanvaardbare proporties blijft. Meer zorg en meer geld maken de zorg niet automatisch sneller beschikbaar. Beter gaat in de eerste plaats om betere zorg voor de patiënt. Het slimmer organiseren van de zorg, soms door nieuwe logistieke afspraken of door het herontwerpen van zorgprocessen levert meestal al meer doelmatigheid en kwaliteit op. Wanneer bij deze veranderingen tevens de klant centraal blijft staan, zullen er ook meer tevreden patiënten zijn. Naast deze slimmere organisatie van de zorg blijven natuurlijk de medische en verpleegkundige innovaties van grote invloed houden op het sneller beter maken van patiënten.

Doelen Sneller Beter

De doelstellingen van Sneller Beter zijn de volgende:

- zichtbaar maken dat veel goed gaat in de zorg;
- goede voorbeelden inventariseren en op een gestructureerde wijze delen;
- structurele verbeteringen op de thema's veiligheid, logistiek en klantgerichtheid versneld implementeren;
- deze verbeteringen ook borgen;
- vergroten van de transparantie van de zorg;
- de sector daarmee voorbereiden op het nieuwe zorgstelsel.

3 pijlers

De Sneller Beter activiteiten zijn geordend naar drie pijlers. In de eerste pijler wordt vooral gewerkt aan bewustwording, kennisontsluiting en kennisverspreiding. Op nagenoeg alle aspecten die relevant zijn voor kwaliteit, innovatie en doelmatigheid organiseer ik daarvoor bijeenkomsten met het veld, van hoog tot laag in de hiërarchie van de ziekenhuizen.

In pijler 2 gaat het vooral om het vergroten van de transparantie en de vergelijkbaarheid van de resultaten van de zorg. In eerste instantie ter ondersteuning van het gefaseerd en gelaagd toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), maar steeds meer als onderdeel van de maatschappelijke verantwoording van de ziekenhuizen zelf.

In de derde pijler laten enkele ziekenhuizen zien dat het mogelijk is om zich op een breed gedeelte van de door hen geleverde zorg te verbeteren en stellen daarmee de nieuwe norm, die door patiënten gevraagd en door verzekeraars gecontracteerd wordt. Een van de onderwerpen is patiëntveiligheid waar het Veilig Incident Melden onderdeel van uitmaakt.

Bijlage 3 Analysemethoden

PRISMA methode

Algemene informatie

PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. De methode is ontwikkeld door van der Schaaf van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor menselijk falen in de chemische procesindustrie, maar wordt momenteel ook toegepast in de staalindustrie, de transportsector en de gezondheidszorg. Het belangrijkste doel van de PRISMA methode is het opbouwen van een kwantitatieve database van incidenten en procesafwijkingen, waaruit conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van optimale verbetermaatregelen "Prevention" wijst op het proactieve uitgangspunt: tijdig leren van (vele kleine) incidenten, zoals fouten en bijna-ongevallen, om latere echte ongevallen te voorkomen. Hiervoor is niet alleen inzicht nodig in de faalfactoren, maar ook in de zogenaamde herstelfactoren ("Recovery"). "Information System" geeft de kwantitatieve en communicatieve inslag aan PRISMA. Hierbij gaat het uitdrukkelijk niet om steeds weer op basis van één enkel (ernstig) incident ad hoc maatregelen te nemen; PRISMA bouwt een database van oorzaken op van vele (vaak kleine) incidenten en bijna-ongevallen zodat de structurele, steeds weer terugkerende patronen van oorzaken zichtbaar worden. Uiteindelijk leidt dit tot een continu inzicht met betrekking tot de twee hoofddoelen van risicomanagement: de mate waarin oorzaken van al bekende problemen succesvol beheerst worden door de organisatie ("Monitoring"); en tijdige signalering van mogelijke nieuwe problemen, door alert eventuele trends in oorzaken van relatief onbekende of onverwachte incidenten te volgen ("Analysis").

De PRISMA methode bestaat uit drie belangrijke componenten, te weten:
1. Incidentbeschrijving
2. Oorzakenclassificatie
3. Vertaalslag naar structurele maatregelen.

Incidenten worden eerst beschreven in de vorm van "oorzakenbomen"; vervolgens worden de "basisoorzaken", die per incident door middel van de bijbehorende oorzakenboom zijn geïdentificeerd, stuk voor stuk geclassificeerd via een theoretisch model van technische, organisatorische en menselijke faaloorzaken; ten slotte wordt periodiek een aantal incidenten integraal geïnterpreteerd in termen van de meest effectieve verbetermaatregelen met behulp van een zogenaamde Classificatie/Actie Matrix [van der Schaaf, 1997].

Hieronder worden de verschillende stappen van de PRISMA methode nader toegelicht.

1. Incidentbeschrijving

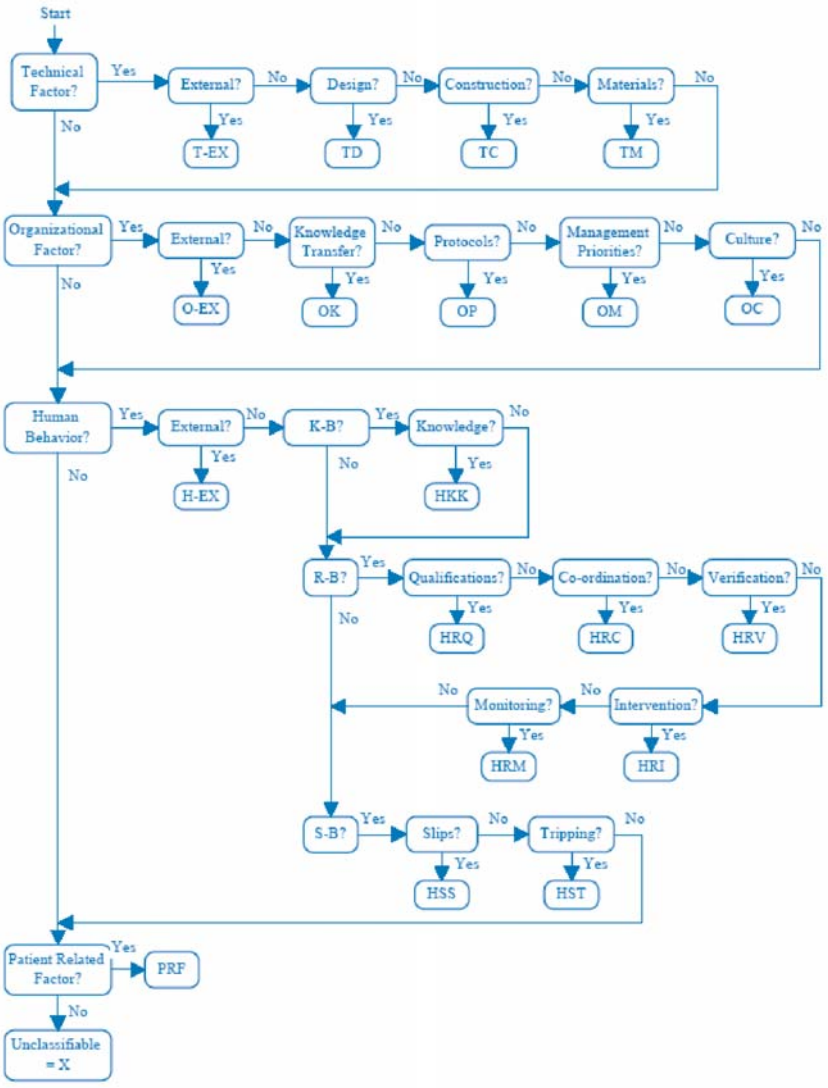
Incidenten worden beschreven met behulp van oorzakenbomen. Oorzakenbomen vormen een visuele representatie van het incident en zijn daarom geschikt om de onderliggende factoren, omstandigheden en beslissingen die een bijdrage hebben geleverd aan het incident te achterhalen. Oorzakenbomen ondersteunen het feit dat bijna alle incidenten meer dan één oorzaak hebben en zij visualiseren de groepering en hiërarchie van die oorzaken. Bovenaan de oorzakenboom staat het symptoom als zichtbare aanleiding voor de analyse: de zogenaamde topgebeurtenis. Onder de topgebeurtenis heeft de oorzakenboom twee zijden: de faalzijde en de herstelzijde. Onder de topgebeurtenis worden alle noodzakelijke directe oorzaken vermeld. Deze directe oorzaken worden weergegeven in zowel logische als chronologische volgorde. Deze directe oorzaken hebben vaak hun eigen oorzaken. Door steeds de "waarom vraag" te stellen, worden alle oorzaken gevonden.

Van boven naar onder vertakt zich zodoende een oorzaak-gevolg structuur, totdat onderaan de oorzakenboom de zogenaamde basisoorzaken gevonden worden. Wanneer de basisoorzaken gevonden zijn, kan er een realistisch beeld verkregen worden van de werking van het systeem en kunnen er effectieve en permanente oplossingen worden gevonden. Er gelden twee "stopregels" voor het construeren van oorzakenbomen:

1. Bouw de oorzakenboom niet verder naar beneden uit als er geen objectieve feiten meer aan te voeren zijn, maar slechts meningen of gissingen.
2. Stop met oorzaken achter oorzaken te zoeken wanneer de systeemgrens overschreden wordt, dat wil zeggen wanneer de bijbehorende maatregelen buiten de invloedssfeer van de organisatie vallen.

2. Oorzakenclassificatie

De in stap 1 gevonden basisoorzaken worden stuk voor stuk geclassificeerd door ze toe te wijzen aan één van de categorieën van het Eindhoven Classificatie Model (ECM). De speciaal voor de (medische) zorgsector ontwikkelde versie is in Figuur 1 afgebeeld.



Figuur 1. Medische versie van het Eindhoven Classificatie Model

Het Eindhoven Classificatie Model is ontstaan door de integratie van specifieke faalmodellen met betrekking tot de techniek, de organisatie en menselijk gedrag. De pijlen volgend in Figuur 1 wordt eerst nagegaan of de materiële omgeving volledig in orde was, vervolgens of de organisatie en het management optimaal waren, om dan pas eventueel te besluiten dat deze ene basisoorzaak van zuiver menselijke aard was.

3. Vertaalslag naar structurele maatregelen

De geclassificeerde basisoorzaken worden opgeslagen in een database, zodat na verloop van tijd, over een groot aantal incidenten heen, de meest frequente (combinaties van) basisoorzaken zichtbaar worden in een zogenaamd PRISMA profiel. Een PRISMA profiel is een grafische weergave van de geregistreerde basisoorzaken van alle incidenten of van een bepaald type incident. Dit zijn dus basisoorzaken die in steeds verschillende "vermommingen" keer op keer bijdragen aan het ontstaan van incidenten. De structurele aanpak hiervan zal waarschijnlijk dus een veel gunstiger kostenbaten verhouding hebben dan ad hoc "oplossingen" na ieder (ernstig) incident afzonderlijk. De zogenaamde Classificatie/ Actie Matrix biedt per oorzaakcategorie ondersteuning voor het formuleren van de meest effectieve verbetermaatregelen.

De volgende acties worden onderscheiden:

- Techniek: herontwerpen van hardware, software of interfaces van het manmachine systeem.
- Procedures: completeren of verbeteren van formele en informele procedures.
- Informatie en communicatie: completeren of verbeteren van beschikbare informatiebronnen en communicatiestructuren.
- Training: verbeteren van (her)training programma's voor de benodigde vaardigheden.
- Motivatie: vergroten van de mate van de vrijwillige opvolging van geaccepteerde regels door de principes van positieve gedragsverandering toe te passen.
- Escalatie: omgaan met de problemen op een hoger organisatorisch niveau.
- Reflectie: evalueren van de huidige gedragspatronen met betrekking tot veiligheid.

(Van der Schaaf, T.W. Prisma methode, medische versie, 2005)

De PRISMA module wordt als e-learning module aangeboden op de website **www.vmszorg.nl.** Met behulp van de module kunt u op een interactieve manier in uw eigen tijd kennis maken met de methodiek zodat u daarna zelf aan de slag kunt.

Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie (SIRE)

Wat is SIRE?

De afkorting SIRE staat voor Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie. Het is een gestructureerde manier om een incident te reconstrueren (Wat is er gebeurd?) en te evalueren (Waarom is het gebeurd?). Het beantwoordt de vraag: hoe kan een vergelijkbaar incident in de toekomst voorkomen worden.

De gedachten achter SIRE is dat er van fouten moet worden geleerd, zodat deze in de toekomst worden ontdekt of opgevangen voordat ze tot schade leiden. De grondgedachte is dat mensen altijd fouten zullen blijven maken. Om processen waarin mensen een rol spelen veiliger te maken, moet bekend zijn welke fouten er gemaakt (kunnen) worden. Hiervoor is het van groot belang dat mensen open kunnen spreken over foute en onveilige situaties en bereid zijn deze te melden. Zolang het bedreigend is om hierover te praten, zullen fouten en onveilige situaties verborgen blijven en pas aan het licht komen tijdens ernstige incidenten. Het belangrijkste kenmerk van SIRE is vrijheid van spreken. De verleidelijke maar verwoestende gewoonte om een schuldige te zoeken wordt dus nauwlettend vermeden.

Door zonder schroom een incident te bespreken, wordt het ontstaan en verloop van het incident inzichtelijk en de kunnen de oorzaken worden benoemd. Met deze kennis kunnen maatregelen worden genomen om de oorzaken weg te nemen, of om te voorkomen dat deze oorzaken opnieuw kunnen leiden tot schade. Ook kunnen factoren die de schade van het incident juist hebben beperkt, worden benoemd en versterkt. Hierdoor wordt de kans op herhaling van soortgelijke incidenten kleiner.

Wat is er nodig om een SIRE te gebruiken?

Om SIRE te gebruiken is er ten eerste iemand nodig, bij voorkeur twee personen, die getraind is in de methode. Hoe vaker iemand een SIRE uitvoert, hoe beter de SIRE zal verlopen.

Ten tweede is er tijd nodig. Het uitvoeren van een complete SIRE kost, afhankelijk van de complexiteit van het incident, 10 tot 24 uur per onderzoeker. Hoewel het is aan te bevelen om een SIRE zo snel mogelijk af te ronden, leert de praktijk dat dit meestal tussen de vier en acht weken duurt.

Ten derde is er ondersteuning nodig vanuit het management. Het management van de afdeling of instelling moet achter het gebruik van SIRE staan, omdat het gebruik enerzijds een tijdsinvestering vergt en anderzijds inzichten en aanbevelingen kan opleveren waar het management iets mee zal moeten doen. SIRE kan het beste worden ingebed in een algemeen kwaliteits- of veiligheidsbeleid.

Wanneer wordt een SIRE gebruikt?

SIRE wordt gebruikt naar aanleiding van een incident. SIRE is het meest effectief bij ernstige of hoogfrequente incidenten. Hier hebben verbeteringen een grotere impact, waardoor de tijdsinvestering die een SIRE vergt een hoger rendement oplevert.

Hoe werkt een SIRE?

SIRE is de Nederlandse vertaling van Root Cause Analysis (RCA). Dit is een overkoepelende term voor incident analyse waarbij systeemdenken, ‘human factors engineering’ en cognitieve psychologie zijn verwerkt. SIRE verloopt volgens een aantal stappen, het

wordt multidisciplinair uitgevoerd, de schuldvraag doet niet ter zake, er wordt net zolang gezocht tot de basisoorzaken zijn benoemd en het heeft tot doel om herhaling van soortgelijke incidenten te voorkomen.

Een SIRE wordt opgebouwd uit zeven stappen:

- Identificeer het incident en verzamel de relevante informatie: melder interviewen, betrokkenen interviewen, patiëntenstatus opvragen, informatie vinden over het proces, de omgeving, materialen en cultuur.
- Maak de verzamelde data inzichtelijk en overzichtelijk: informatie sorteren, chronologie maken.
- Identificeer het probleem en maak zo nodig een prioritering: beslissen wat belangrijke momenten waren m.b.t. het incident, kiezen waar het onderzoek zich op gaat richten.
- Onderzoek het probleem nauwkeurig: incidenten analyseren, barrières en vangnetten beoordelen, zonodig multidisciplinaire groep bijeenbrengen, creatieve technieken gebruiken.
- Identificeer mogelijke interventies om de veiligheid en/of kwaliteit te verbeteren: bedenken hoe herhaling van soortgelijke incidenten voorkomen kan worden, aanbevelingen toetsen op haalbaarheid.
- Maak een verslag: onderzoeksbevindingen en aanbevelingen opschrijven.
- Rond de SIRE af: rapport geven aan de opdrachtgever, verzamelde informatie vernietigen, informeren over de reactie op het rapport, reactie terugkoppelen aan de betrokkenen.

(Leistikow I.P., den Ridder, K. Patiëntveiligheid, systematische incident reconstructie en evaluatie. 2005)

Bijlage 4 Incidenten meldingsformulieren en meldprocedure

Voorbeeld NHS

Kettering General Hospital NHS Trust

Confidential - Report of an incident involving actual or potential harm to patients, staff or visitors (near miss)

Use BLOCK CAPITALS, continue on a separate sheet if necessary

1. Identity No.	**2.** ☐ Incident ☐ Near miss ☐ Hazard
3. Details of PERSON INVOLVED or affix PATIENT STICKER Name(s) Date of Birth Unit Number Age Ethnic Group ☐ Male ☐ Female	**Where did the incident occur?** Exact location - e.g. Ward of Department: Please state Directorate First Aid Administered: ☐ Yes ☐ No To whom:
4. When did the incident occur?	Date Time (24 hour clock):
5. Persons(s) involved: ☐ Patient ☐ Staff ☐ Visitor Actual or Potential Loss* * Please circle appropriate response **None / Minor / Moderate / Major* / Catastrophic*** (see guidance for definitions) * In the case of a major or catastrophic incident, reporting must be immediate to the DGM or Director on call irrespective of time of day.	
6. Additional persons involved/present if staff member, give grade	
7. What happened? Give a *factual account not opinion* of the incident, including a description if any: ☐ medical devices, equipment or property involved ☐ medicines involved ☐ why incident/near miss happened ☐ security issues ☐ violent incident or aggression issues* ☐ fire safety issues** ☐ accidental damage to property ☐ malicious damage to property ☐ manual handling ☐ participant in clinical trial/research (if yes notify R&D Co-ordinator) * complete Physical Assault Report System form and inform Security Advisor ** also report to fire officer	Continue on a separate sheet if necessary
8. ☐ **Was a medical device/piece of equipment involved?**	Reported to Medical Electronics Manager? ☐ Reported to Medical Equipment Library? ☐
9. Has, or will information on this incident be reported to any other agency / body?	☐ Medical Device Agency ☐ Regional Health Authority ☐ Health and Safety Executive ☐ Other (specify) ☐ Confidential Enquiry

10. Reporter's Name and Details	**Name:**	**Job title:**
	Telephone:	**Bleep:**
	Directorate:	**Signed:**
	Date:	

For an incident involving **DRUGS**, please complete question **11** overleaf, otherwise move to question **12**.

Only in the case of an incident involving drugs complete esction 11:

11. What was prescribed?	Drug prescribed: (form and strength etc.)
Date and time prescribed	
Dosage prescribed	
Route prescribed: *Oral / IV / IM / Subcutaneous / Other	(*delete as appropriate)

See Form 2 (scoring of drug incident) and guidelines for management action ☐ **(Total Score from Form 2)**

12. Immediate action taken to manage the incident or near miss by Manager or Member of Staff involved (To be completed in all instances)

Was a Risk Assessment necessary in relation to the incident? ☐ Yes ☐ No

Was a Risk Assessment in place prior to the incident? ☐ Yes ☐ No

What immediate steps were taken to minimise the likelihood of a reoccurrence of the incident being reported?

Action Plan ☐ Yes ☐ No ☐ Not Applicable (where no action required)

Action(s) to be implemented by (the following named individual(s)

Implementation Date

Action to be monitored / reviewed by (the following named individual(s)

Monitoring / Review Date

PRINT Name of manager with overall responsibility for the plan.	Signature	Complete Date

Consequence					
Likelihood	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
Almost Certain	5 Yellow	10 Yellow	15 Orange	20 Red	25 Red
Likely	4 Yellow	8 Yellow	12 Orange	16 Red	20 Red
Possible	3 Green	6 Yellow	9 Orange	12 Red	15 Red
Unlikely	2 Green	4 Green	6 Yellow	8 Orange	10 Red
Rare	1 Green	2 Green	3 Yellow	4 Orange	5 Red

Score of Incident using the Risk Matrix

THANK YOU FOR TAKING THE TIME AND TROUBLE TO HELP IMPROVE SAFETY IN THE NHS

Please return completed forms to

Non-clinical incidents - Health and Safety Department
Clinical incidents - Clinical Governance Support Unit
Drug incidents - Pharmacy

Voorbeeld meldformulier Isala klinieken (versie 2006)

VIM Veilig Incident Melden Isala
VERTROUWELIJK

Ponsplaatje / sticker patiënt

Datum melding: ……. /…….. /200……
Melder functie: Naam Hoe bereikbaar

Formulier helemaal invullen! Criterium voor melden: 'alles wat niet de bedoeling was' m.b.t. de zorg rondom een patiënt. Kies eerst een item uit één van de vier hoofdcategorieën in de eerste kolom. Vul vervolgens de andere kolommen in (meerdere antwoorden mogelijk) en daarna de achterzijde van het formulier.

1 Medicatie / voeding	(Bijna-)incident	Hoe werd het (bijna-)incident ontdekt?
☐ Medicatie, naam:	☐ Foutieve dosis / hoeveelheid	☐ Controle van de patiënt
☐ Bloed/bloedproducten, nl	☐ Foutieve concentratie	☐ Controle afspraken tijdens dienst
☐ Enterale voeding:	☐ Verkeerde inloopsnelheid	☐ Inspectie daglijst
☐ per os, nl	☐ Verkeerde patiënt	☐ Controle afspraken tijdens dienstoverdracht
☐ per sonde, nl	☐ Onvolledige intake	☐ Ontdekking door alarm (welk?)
☐ Parenterale voeding:	☐ Verkeerd product	☐ Anders, nl
☐ vetten	☐ Verlopen product	
☐ eiwit/glucose	☐ Verkeerd tijdstip	
☐ Anders, nl	☐ Foutieve toedieningsroute	
	☐ Anders, nl	
2 Onderzoek	**(bijna-)incident**	
☐ Laboratoriumonderzoek	☐ Onnodige afname	
☐ Röntgenonderzoek	☐ Materiaal niet ontvangen	
☐ Echografisch onderzoek	☐ Verkeerd materiaal afgenomen	
☐ Anders, nl	☐ Verkeerde aanvraag	
	☐ Verkeerd tijdstip	
	☐ Verkeerde patiënt	
	☐ Onderzoek niet verricht	
	☐ Vertraagde uitslag	
	☐ Anders, nl	
3 Materialen/apparatuur	**(Bijna-)incident**	**Het (bijna-)incident vond plaats**
☐ Sonde, type	☐ Ongeplande verwijdering	☐ bij opname op afdeling
☐ Pomp, type	☐ Verstopt	☐ tijdens verblijf op afdeling
☐ Verbandmateriaal, nl	☐ Geknikt	☐ bij overplaatsing intern/extern
☐ Catheter, type	☐ Losraking	☐ tijdens ontslag
☐ Drain, type	☐ Niet meer in situ	☐ tijdens acute situatie, nl
☐ Perifeer infuus	☐ Te diep gezogen	☐ tijdens pauze van verantwoordelijk verpleegkundige
☐ CVL (ligging)	☐ Verkeerd aangesloten	☐ tijdens overdracht/visite
☐ Arterielijn (ligging)	☐ Te lang in situ	☐ weekend
☐ Zuigslang,type	☐ Subcutaan lopend infuus	☐ anders, nl
☐ Bevochtiging, type	☐ Onjuiste instelling	
☐ Low flow, nl	☐ Onjuist gebruik	
☐ CPAP, nl	☐ Disfunctie apparaat	
☐ Tube, type	☐ Beschadiging	
☐ Trachea canule, type	☐ Onbeschikbaar	
☐ Beademingsslang, type	☐ Anders, nl	
☐ Beademingsmachine, type		
☐ Monitor, type		
☐ Anders, nl		
4 Andere melding		
☐ Beschrijving z.o.z.		

Beschrijf het (bijna-)incident zo gedetailleerd mogelijk, inclusief factoren die de gevolgen van het (bijna-)incident hebben beperkt.

Hoe zou dit (bijna-)incident in de toekomst voorkómen kunnen worden?

Datum en tijdstip incident: ..... /..... /200... ..... : ..... uur ☐ onbekend
Datum en tijdstip ontdekken: ..... /..... /200... ..... : ..... uur ☐ onbekend

Het (bijna-)incident…

☐ Werd ontdekt voordat het de patiënt kon bereiken
☐ Heeft de patiënt bereikt

Incident aan patiënt / ouders / contactpersoon gemeld?

☐ Ja, reactie:
☐ Nee, reden:

Feitelijke gevolgen voor de patiënt ten tijde van melding:

☐ Geen ongemak of letsel
☐ Klein letsel, geen verlengde opnameduur
☐ Ernstig tijdelijk letsel, verlengde opnameduur
☐ Ernstig permanent letsel, verlengde opnameduur
☐ Overlijden
☐ Onbekend

Gegevens patiënt

Eventuele. aanvullingen

Personeelslid betrokken bij ontdekken

☐ Verantwoordelijke verpleegkundige
☐ Verpleegkundige in opleiding voor
☐ Specialist, nl
☐ Arts-assistent
☐ Co-assistent
☐ Anders, nl
☐ Onbekend

Personeelslid betrokken bij ontstaan

☐ Verantwoordelijke verpleegkundige
☐ Verpleegkundige in opleiding voor
☐ Specialist, nl
☐ Arts-assistent
☐ Co-assistent
☐ Anders, nl
☐ Onbekend

In te vullen door commissie

Mogelijke gevolgen patiënt:
☐ Gering
☐ Klein
☐ Matig
☐ Groot
☐ Extreem / catastrofaal
☐ Onbekend

Herhaling
☐ Zeldzaam
☐ Onwaarschijnlijk
☐ Mogelijk
☐ Waarschijnlijk
☐ Vrijwel zeker

Risico inschatting
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

Actie
☐ Direct naar MIP
☐ Analyse door commissie
☐ Geen nadere analyse

Terugkoppeling melder: Persoonlijk / Overzicht

Acties n.a.v. melding:

Meldprocedure Isala klinieken

De meldprocedure zal in elk ziekenhuis verschillend zijn. De meldprocedure van de Isala klinieken wordt hierbij als voorbeeld gegeven. De procedure is gebaseerd op het vier route systeem van de Bekker/van der Steeg (2004). Het gaat er vanuit dat het managen van risico's via vier sporen kan lopen, waarin de verantwoordelijkheden en informatie-stromen duidelijk zijn weergegeven. Dit sluit aan bij de heersende opvattingen over integraal management en decentrale verantwoordelijkheden en maakt patiëntveiligheid tot een logisch onderdeel van de bedrijfsvoering.

Meldingen categorie 1 + 2	Meldingen categorie 1+2+3	Meldingen categorie 4	Calamiteiten categorie 4
Route 1 Individueel	***Route 2*** Patiëntveiligheid Commissie (PVC)	***Route 3*** MIP commissie	***Route 4*** Raad van Bestuur
Eerste hulp bij incidenten	melden registreren	melden registreren trendanalyse	melden IGZ intern onderzoek
rapportage in dossier aanpassing behandeling	analyseren (DAM) maatregelen registreren	analyse adviseren RvB maatregelen verspreiden kennis	rapportage RvB maatregelen

Route 1: individueel
Als er een (bijna) incident gebeurt, is het in eerste instantie van belang dat eerste hulp wordt verleend. De arts en/of verpleging treft maatregelen bij de patiënt om de schade zoveel mogelijk te beperken en zoveel mogelijk te herstellen. De arts of verpleegkundigen rapporteert het incident in het patiëntendossier en meldt het (bijna) incident aan de behandeld arts en leidinggeven om te beoordelen of het behandelplan aangepast moet worden. Het (bijna) incident wordt besproken met de patiënt. Tevens wordt het incident via een meldingsformulier gemeld aan de patiëntveiligheidscommissie. In het geval van een calamiteit dient de leidinggevende dan wel behandelend arts dit direct te melden aan de Raad van Bestuur. Calamiteiten worden verder afgehandeld volgens route 4.

Route 2: Patiënten Veiligheids Commissie (PVC)
Een omgeving waar men het vertrouwen en de veiligheid voelt om ongewenste gebeurte-nissen te melden is met name op zorgteam niveau te realiseren.
De decentrale opgezette multidisciplinaire Patiënt Veiligheids Commissie (PVC) per zorgteam is een succes gebleken zowel binnen de neonatologie intensive care als ook binnen de diverse zorgteams van de zorggroep chirurgie. De belangrijke succesfactor zit hem in het feit dat door het bespreken/analyseren van de (bijna) incidenten, door zowel de verpleeg-kundige/ vakinhoudelijke- als de medisch discipline, de kwaliteit van de zorg weer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt ervaren.

Samenstelling PVC

Om de (bijna-)incidenten goed te kunnen analyseren is zowel medisch inhoudelijke als verpleegkundige/vakinhoudelijke expertise van groot belang. Daarom moeten beide disciplines vertegenwoordigd zijn in de PVC. Tevens is van belang de commissies binnen diverse zorgteams op uniforme wijze te laten functioneren en continuïteit te waarborgen. De commissie dient dan ook in ieder geval te bestaan uit de volgende vaste commissieleden:

- een medisch coördinator
- een hoofd zorgteam
- drie teammedewerkers (één van de drie met aandachtsgebied kwaliteit), waarvan er één als voorzitter zal optreden.

Desgewenst kan men de commissie aanvullen met extra artsen of verpleegkundigen/ beroepsbeoefenaren en leden die belast worden met organisatorische taken of het beheren van de database.

Het proces van een melding stap voor stap

- Een (bijna) incident wordt ingevuld op het meldingsformulier of digitaal en ingeleverd op de daarvoor afgesproken plaats (kan per zorgteam verschillen).
- De melding wordt bekeken door één van de PVC leden. Dit PVC lid beoordeelt of de informatie op het meldingsformulier voldoende duidelijk is om het (bijna)incident te analyseren. Is dit niet het geval dan wordt er door het PVC lid aan de melder nadere vragen gesteld. Is de informatie op het meldingsformulier compleet, dan deelt het PVC lid het (bijna) incident al voorlopig in volgens de ernst/risico matrix (zie bijlage 5).
- In overleg met het hoofd zorgteam zal per melding worden bekeken of direct (ad hoc) actie moet worden ondernomen of dat dit op een meer systematische manier later kan plaatsvinden.
- Een incident vallend onder ernst/risico matrix “zeer hoog” direct doorsturen naar de centrale MIP-commissie en snel complete informatie te verzamelen zolang het medisch dossier/ patiënt nog op de afdeling is. Check of de patiënt is ingelicht. Wordt er te lang gewacht met het onderzoek en communiceren met de patiënt dan blijkt het een en ander erg moeizaam te achterhalen.
- Ter voorbereiding op de PVC bijeenkomst zoekt de voorzitter van alle bijna- incidenten een aantal voorbeelden met de hoogste risicoscore uit om deze te analyseren volgens de Decentral Analyse Methode. Het Hoofd zorgteam/ of medisch coördinator zorgt dat tijdens de PVC bijeenkomst de medische status van de te analyseren (bijna)incidenten, aanwezig is.
- Meldingen worden waar mogelijk voorgelegd aan werkgroepen of subcommissies om structurele oplossingen te bedenken.
- Indien acties worden gepland, dient de uitvoering hiervan te worden genoteerd en gecontroleerd.
- Na de PVC bijeenkomst wordt er een samenvatting van de bespreking waarin aantallen, indeling volgens de ernst/risicomatrix met daarbij de te ondernemen acties, gemaakt. Tevens worden de meldingen in de database gevoerd.

Bijlage 5 Risicomatrix: prioriteren op basis van risico-inschattingCategorisering ernst

		ERNST			
		Catastrofaal Ca	Groot Gr	Matig Ma	Klein Kl
Frequentie	Wekelijks We	Zeer hoog	Zeer hoog	Hoog	Laag
	Maandelijks Ma	Zeer hoog	Hoog	Laag	Zeer laag
	Jaarlijks Ja	Hoog	Laag	Laag	Zeer laag
	Minder dan 1x per jaar<Ja	Laag	Zeer laag	Zeer laag	Zeer laag

Categorisering ernst

Code	Categorie	Definitie
Ca	Catastrofaal	Overlijden / ernstig blijvend letsel
Gr	Groot	Niet ernstig blijvend letsel
Ma	Matig	Niet blijvend letsel
Kl	Klein	Geen letsel

Categorisering frequentie

Code	Categorie
We	Wekelijks
Ma	Maandelijks
Ja	Jaarlijks
<Ja	Minder dan 1x per jaar

Afgaande van de kleur van de cel in risicomatrix kunnen afspraken worden vastgelegd over wie verantwoordelijk is voor het ondernemen van actie.
Zo zou de afspraak kunnen zijn dat als de score in het donkere blauw komt, dit aanleiding is om het voorval bij de Raad van Bestuur neer te leggen.

Bijlage 6 Referenties

Publicaties

1. De Bekker & van der Steeg.
2. Bekker J de. Patiënt en incident, de MIP in 100 vragen. 2006
3. Everdingen J.J.E et al (red). Praktijkboek patiëntveiligheid. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2006
4. Hiddema U.F et al. Een oplettende blik. Medisch Contact 2003; 58 (34): 1263-5. 3.
5. IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Staat van de gezondheidszorg. Den Haag, 2004
6. Kaplan et al Identification and classification of causes of events in transfusion medicine. TRANSFUSION 1998; volume 38: 1071-1081
7. Kingma JH. Primum nil nocer. Medisch contact 203; 58: 391
8. Leape, Lucian l., Reporting of adverse events, N Engl J Med, Vol. 347, No. 20, nov 14, 2002, 1633-1638
9. Legemaate, J. et al Melden van incidenten in de gezondheidszorg. 2006
10. Leistikow I.P., den Ridder, K. Patiëntveiligheid, systematische incident reconstructie en evaluatie. 2005
11. Milligan F, Bird, D. Adverse health-care events: Part 4, challenge of a blame free culture. Prof Nurse 2003; 12: 705-709
12. Molendijk A, Borst K, Van Dolder R. Vergissen is menselijk, Medisch Contact 2003; 58 (43): 1658-1662
13. Pronk EJ. Waarom het goed ging. Analyse van bijna-missers verbetert de patiëntveiligheid. Medisch Contact 2004; 59 (4): 105-8.
14. Pronk EJ. Shell helpt. Medisch Contact 2004; 28/29
15. Pyrek Km. Ending the 'blame game' Infection Control Today (2004)
16. Reason J. Human error: models and management. BMJ; 2000; 320: 768770
17. Runciman W.B. et al. Errors, Incidents and Accidents in Anaesthetic Practice, Anaesth Intens Care 1993; 21: 506-519
18. Schellekens W, Blijham G. Deltaplan voor een verborgen probleem. Medisch Contact 2003; 58 nr. 10: 387-390
19. Van der Schaaf, T.W. Prisma methode, medische versie, 2005
20. Vincent Ch. Understanding and Responding to Adverse Events. N ENGL J MED 2003; 348;11: 1051-1056
21. Willems, R. Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Shell, 2004
22. WU A.W. et al. Do house officers learn from their mistakes? Qual Saf Health Care 2003; 12:221-228
23. WU A.W., Pronovost P. et al. ICU Incident Reporting Systems. Journal of Critical Care, Vol 17, No 2 (june), 2002 pp 86-94

Websites

Australian Patient Safety Foundation: www.apsf.net.au

Australian Council for Safety and Quality in Health Care: www.safetyandquality.org

Complicatieregistratie: www.orde.nl/complicatieregistratie/publicaties

Definitielijst patiëntveiligheid, Inspectie voor de Gezondheidszorg: www.igz.nl

Institute for Healthcare Improvement, USA: www.ihi.org

Institute of Medicine, USA: www.iom.edu

VA National Center for Patient Safety USA: www.patientsafety.gov

National Patient Safety Agency UK: www.npsa.nhs.uk

Platform Patiëntveiligheid: www.platformpatiëntveiligheid.nl

Project Veiligheidsmanagement: www.vmszorg.nl

Sneller Beter: www.snellerbeter.nl

De VMS Zorg partners

NVZ vereniging van ziekenhuizen

De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
www.nvz-ziekenhuizen.nl

Orde van Medisch Specialisten

De Orde van Medisch Specialisten (Orde)
www.orde.nl

LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging

Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV)
www.levv.nl

Met medewerking van:

Sneller Beter ++++
PIJLER 3

VMS
Bouwen aan veiligheid in de zorg

Auteurs

Mw. drs. B. Th. Heemskerk,
Orde van Medisch Specialisten

Mw. dr. M. C. Stadlander,
Orde van Medisch Specialisten

Mw. drs. H. Tijink,
Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO

Mw. drs. M. M. Houtsma,
Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO

Mw. drs. E. P. M. Werther-Voorrecht,
NVZ vereniging van Ziekenhuizen

VMS Zorg
Postbus 20057 - 3502 LB Utrecht
Telefoon (030) 28 23 689
E-mail: info@vmszorg.nl
Website: www.vmszorg.nl

Utrecht, mei 2007